

FICHA TÉCNICA MONOGRÁFICA DE EVALUACIÓN CLÍNICA

CRITERIOS DE LAXITUD ARTICULAR DEL HOSPITAL DEL MAR (BULBENA)
Hospital del Mar Hyperlaxity Criteria (Bulbena et al., 1992, 2004) · IMIM Hospital del Mar, Barcelona

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL Y FICHA RESUMEN

Nombre oficial	Criterios de Laxitud Articular del Hospital del Mar (Bulbena Criteria for Hypermobility)
Sigla / Acrónimo	Laxitud-HdM
Autoría original	Antonio Bulbena, J. C. Duró, M. Porta, S. Faus, R. Mateo et al. (IMIM Hospital del Mar, Barcelona, 1992)
Marco de referencia	Validado y refinado en España; ampliamente replicado en psiquiatría biológica y reumatología internacional
Constructo evaluado	Hipermovilidad articular generalizada como marcador somatofenotípico de vulnerabilidad a trastornos de ansiedad
Población diana	Población general, pacientes con pánico, agorafobia, fobia social, dolor musculoesquelético difuso y Ehlers-Danlos
Tiempo de aplicación	5 a 8 minutos (exploración física articular estandarizada en camilla/consulta)
Estructura y formato	10 maniobras clínicas de movilidad articular bilateral (puntuación dicotómica 0 o 1 por maniobra)
Condiciones de uso	Dominio público para práctica asistencial y científica no comercial (Hospital del Mar / IMIM)

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y MODELO TEÓRICO

El Síndrome de Hiperlaxitud Articular (SHA) o Trastorno del Espectro de Hipermovilidad no es meramente una anomalía del aparato locomotor, sino un trastorno sistémico del tejido conectivo con profunda implicación neuropsiquiátrica. A finales de la década de 1980, el equipo psiquiátrico de Antonio Bulbena en el Hospital del Mar de Barcelona descubrió un hallazgo paradigmático: los pacientes con Trastorno de Pánico y Agorafobia presentan una prevalencia de hiperlaxitud articular hasta **16 veces superior** a la observada en controles sanos (67% vs. 10%).

A nivel fisiopatológico, las mutaciones sutiles en las fibras de colágeno no solo generan distensibilidad ligamentosa y fragilidad capilar, sino que afectan las paredes vasculares periféricas y las terminaciones nerviosas autonómicas. Esto origina una insuficiencia venosa reactiva, labilidad simpática (taquicardia postural ortostática / POTS), hiperreactividad amigdalina y una interocepción amplificada, lo que predispone genéticamente a ataques de pánico y ansiedad somatomorfa. Los criterios del Hospital del Mar fueron creados para superar las limitaciones de la escala de Beighton al incorporar articulaciones proximales y periféricas clave.

3. LAS 10 MANIOBRAS CLÍNICAS EXPLORATORIAS (BULBENA)

Nº	Maniobra Articular	Criterio Positivo	Estructura Anatómica y Técnica
1	Dorsiflexión 5º dedo	≥ 90 grados	Dorsiflexión pasiva del meñique con mano plana en mesa
2	Aposición pulgar-antebrazo	Contacto pasivo	Flexión pasiva del pulgar hacia la cara volar del antebrazo
3	Hiperextensión de codo	> 10 grados	Extensión pasiva del codo más allá de los 180º neutros
4	Hiperextensión de rodilla	> 10 grados	Genu recurvatum pasivo con paciente en decúbito supino
5	Flexión tronco suelo	Palmas en el suelo	Flexión anterior de tronco sin doblar las rodillas
6	Rotación externa de hombro	> 85 grados	Brazo pegado al cuerpo y codo a 90º; rotación externa forzada
7	Rotación externa de cadera	> 60 grados	Paciente en prono con rodillas a 90º; rotación externa pasiva
8	Dorsiflexión de tobillo	> 15 grados	Dorsiflexión pasiva de tobillo con rodilla en flexión de 90º
9	Hiperextensión metatarsofalángica	> 90 grados	Extensión pasiva del primer dedo del pie hacia la pierna
10	Equimosis fácil / Piel hiperelástica	Evidencia clínica	Signo de colágeno laxo: hematomas espontáneos y piel elástica

EVALUACIÓN PSICOMÉTRICA, BAREMACIÓN Y CÓMPUTO CLÍNICO

4. RENDIMIENTO CLÍNICO Y CORRELATOS NEUROPSIQUIÁTRICOS

Fiabilidad interobservador	Excelente concordancia entre examinadores clínicos independientes; índice Kappa $\kappa = 0.82 - 0.89$ en el estudio original del Hospital del Mar (Bulbena et al., 1992).
Sensibilidad y especificidad	Sensibilidad del 87% y especificidad del 89% frente a los criterios diagnósticos reumatológicos de Carter y Wilkinson y la escala de Beighton.
Asociación con ansiedad	Odds Ratio (OR) = 10.8 (IC 95%: 4.2 - 27.5) para Trastorno de Pánico; OR = 5.4 para Agorafobia; asociación demostrada con mayor reactividad ante inhalación de CO_2 .
Validez de constructo	Análisis de componentes principales valida la distribución homogénea de hiperlaxitud que integra miembros superiores, inferiores y esqueleto axial.
Marcador genético-familiar	Agregación familiar demostrada; co-heredabilidad de la hiperlaxitud y la vulnerabilidad a fobias y ansiedad paroxística episódica.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÓMPUTO DE PUNTUACIONES

Exploración bilateral	En las maniobras de miembros pares (ítems 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9), la maniobra se califica como positiva (1 punto) si se cumple en al menos uno de los lados (o en ambos).
Puntuación directa global	Suma lineal aritmética de los ítems positivos. Rango teórico posible: 0 a 10 puntos .
Ajuste por edad	La laxitud disminuye fisiológicamente con el envejecimiento (1 punto cada dos décadas tras los 30 años); en mayores de 50 años indagar antecedentes de contorsionismo juvenil.
Estratificación por sexo	Los umbrales diagnósticos de positividad difieren por dimorfismo sexual biomecánico (mayor flexibilidad ligamentosa estrogénica en mujeres).

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA

Puntos (0-10)	Población	Categoría	Significación Clínica y Pronóstico
0 - 3 puntos	70 - 80%	Laxitud Normal / No Hiperlaxo	Sin anomalías de movilidad articular generalizada.
4 puntos	10 - 15%	Hipermovilidad Límite	Positivo en varones; límite en mujeres. Vulnerabilidad autonómica leve.
5 - 7 puntos	10 - 12%	Hiperlaxitud Articular Positiva	Fenotipo hiperlaxo consolidado. Fuerte correlato con pánico y disautonomía.
8 - 10 puntos	< 3%	Hiperlaxitud Severa / Extrema	Riesgo de subluxaciones articulares recurrentes y Ehlers-Danlos hiperlaxo.

PUNTOS DE CORTE DIAGNÓSTICOS OFICIALES (BULBENA ET AL.):

- **Mujeres:** Puntuación $\geq \frac{5}{10}$ puntos: Criterio de Hiperlaxitud Positiva.
- **Varones:** Puntuación $\geq \frac{4}{10}$ puntos: Criterio de Hiperlaxitud Positiva.

La presencia de hiperlaxitud positiva multiplica por 10 el riesgo de crisis de angustia paroxísticas y por 6 la probabilidad de intolerancia a betabloqueantes o ansiolíticos comunes.

DECISIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO, SEGURIDAD Y BIBLIOGRAFÍA

7. ALGORITMO DE DECISIÓN CLÍNICA EN PACIENTES CON ANSIEDAD Y LAXITUD

Paso 1: Exploración Somática en Trastornos de Ansiedad: Realizar la maniobra rápida de Bulbena en todo paciente con crisis de pánico, agorafobia o disautonomía.

Paso 2: Si el Criterio es Negativo (< 5 en mujeres, < 4 en varones): Abordaje psiquiátrico y psicoterapéutico estándar (TCC convencional e ISRS).

Paso 3: Si el Criterio es Positivo (Hiperlaxitud Confirmada):

- **Psicoeducación Neurobiológica:** Explicar al paciente que sus palpitaciones y sensaciones de mareo no son "locura", sino una desregulación autonómica real mediada por colágeno laxo y pooling venoso.
- **Manejo Autonómico Coadyuvante:** Prescribir medidas posturales, aumento de sal y agua (si no hay contraindicación) y ejercicio isométrico para evitar el pooling periférico.
- **Precaución Farmacológica:** Evitar psicofármacos hipotensores ortostáticos que agraven la taquicardia refleja (tricíclicos, quetiapina).

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO DE TRASTORNO DE PÁNICO Y COLÁGENO LAXO

Identificación: Mujer de 28 años remitida a Salud Mental tras acudir en reiteradas ocasiones a Urgencias por palpitaciones súbitas, mareo al levantarse, sensación de muerte inminente y agorafobia en centros comerciales.

Exploración Articular Bulbena: Puntuación = 7 / 10 (Hiperlaxitud Articular Positiva).

- Maniobras positivas: Aposición del pulgar bilateral (1); Dorsiflexión del 5º dedo > 90° (1); Hiperextensión de codos > 15° (1); Hiperextensión de rodillas (1); Flexión de tronco palmas en suelo (1); Rotación de hombro (1); Equimosis fácil con microtraumatismos (1).

Diagnóstico Integrado: Trastorno de Pánico con Agorafobia y Fenotipo Neuroconectivo de Hiperlaxitud Articular (Síndrome de Ehlers-Danlos Hiperlaxo con intolerancia ortostática comórbida).

Plan Terapéutico: 1) Psicoeducación somatosensorial para reinterpretar la taquicardia ortostática; 2) Entrenamiento en fuerza isométrica muscular de miembros inferiores; 3) Sertralina 50 mg/día asociada a medidas posturales de hidratación.

Evolución a los 6 meses: Remisión total de las visitas a urgencias, cese de las crisis de angustia y normalización de la autonomía de desplazamiento en transporte público.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Banderas Rojas y Riesgos Médicos:

- **Aneurismas y Prolapso Mitral:** En pacientes con hiperlaxitud extrema y estigmas vasculares, solicitar ecocardiograma transtorácico (descartar prolapso mitral y dilatación aórtica).
- **Luxaciones Recurrentes:** Luxación recidivante de hombro o rótula; evitar deportes de impacto sin estabilización previa.

Diagnóstico Diferencial:

- **Trastorno de Pánico Puro vs. Neuroconectivo:** En pacientes hiperlaxos, el componente autonómico e interoceptivo corporal es dominante.
- **Síndrome de Ehlers-Danlos Vascular (Tipo IV):** Caracterizado por fragilidad arterial y de vísceras huecas; exige consejo genético inmediato.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (FORMATO APA 7ª ED.)

- Bulbena, A., Duró, J. C., Porta, M., Faus, S., Vallescar, R., & Molina, R. (1992). Clinical assessment of hypermobility of joints: assembling criteria. *The Journal of Rheumatology*, 19(1), 115-122.
- Bulbena, A., Gago, J., Pailhez, G., Sperry, L., Fullana, M. A., & Vallescar, R. (2004). Joint hypermobility syndrome is a risk factor for anxiety disorders. *The British Journal of Psychiatry*, 184(5), 433-437. <https://doi.org/10.1192/bjp.184.5.433>
- Bulbena, A., Baeza-Velasco, C., Bulbena-Cabré, A., Pailhez, G., Critchley, H., Chopra, P., et al. (2017). Psychiatric and psychological aspects in the Ehlers-Danlos syndromes. *American Journal of Medical Genetics Part C: Seminars in Medical Genetics*, 175(1), 237-245. <https://doi.org/10.1002/ajmg.c.31554>
- Baeza-Velasco, C., Gély-Nargeot, M. C., Bulbena-Cabré, A., & Bulbena, A. (2011). Joint hypermobility syndrome in primary care: an unrecognized condition. *Atención Primaria*, 43(8), 444-445.